

Диагностика и хирургическое лечение обтурационной толстокишечной непроходимости

Курбонов К.М., Шамсиев Г.Х., Шарипов Х.Ю., Назаров Х.Ш.

Кафедра хирургических болезней №1, (зав.- член. корр. АН РТ, проф. Курбонов К.М.)

Введение

Наряду с ростом заболеваемости раком ободочной кишки в настоящее время отмечено значительное увеличение числа больных с осложненным его течением и одной из наиболее актуальных, в неотложной абдоминальной хирургии, является проблема диагностики и лечения осложнений рака ободочной кишки[2,3]. Хотя, в последние десятилетия достигнуты некоторые успехи в лечении этой категории больных, однако послеоперационная летальность после радикальных оперативных вмешательств по данным разных авторов колеблется от 41,6% до 48,8% (1,2). Среди осложнений одно из первых мест занимает острая толстокишечная непроходимость, которая встречается от 20,0 до 85,5%.(3). Непроходимость кишки при локализации опухоли в левой половине (сигмовидная, нисходящая ободочная и прямой кишки) в 2-3 раза выше, чем при локализации в правой. Причиной летальных исходов служат: несвоевременная диагностика, позднее обращение больных, отсутствие квалифицированных специалистов в отдаленных районах от центра, увеличение числа больных преклонного возраста и наличие тяжелых сопутствующих патологий со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

От своевременной диагностики и оказанной квалифицированной помощи зависит дальнейшая судьба этих пациентов.

Цель исследования

- улучшение диагностики и непосредственных результатов хирургического лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимости (ОТН).

Материалы и методы

В клинике хирургических болезней №1 за период с 1998 по 2008 г. находилось 77 больных с ОТН, в возрасте от 38 до 80 лет. Женщин было 45 (61,4%), мужчин -32 (38,6%). Около 55% больных были в возрасте 60-70 лет.

Всем поступившим больным проведены клинко-лабораторные, инструментальные методы исследования, включая УЗИ, ирригографию, по показаниям колоноскопию, КТ и МРТ и комбинированную методику исследования разработанную в клинике а также видеолaparоскопию при трудных случаях. При изучении анализа причин запущенности заболевания, оказалось, что 43 (55,8%) поздно обратились за медицинскую помощь, а 34 пациентам (44,2%) поздно поставлен диагноз, из-за отсутствия онкологической настороженности врачей первичного звена.

Результаты и их обсуждение. Анализ обращения больных за медпомощью и сроки госпитализации свидетельствуют о поздних сроках госпитализации. Следует отметить, что лишь 17 больных из 77, госпитализированы в первые 24 часа от момента заболевания, остальные 50 (64,9%) поступали поздно.

При поступлении большинство пациенты имели со-

путствующие заболевания (таблица №1).

Таблица №1. Сопутствующие заболевания у больных с ООТН

Сопутствующие заболевания	Количество	%
Ишемическая болезнь	19	24,6
Гипертоническая болезнь	10	12,9
Атеросклероз сосудов	9	11,7
Хроническая легочная патология	5	6,5
Заболевания почек	4	5,2
Сахарный диабет	7	9,1
Прочие	6	7,8
Всего	60	77,8

Необходимо отметить, что у более 50% больных имело место сочетание двух и более сопутствующих заболеваний.

Дальнейшее изучения клинического материала выявило частоту локализации патологического процесса (таблица2).

Таблица №2. Распределение больных в зависимости от локализации опухоли

Локализация опухоли	Количество больных	%
Ректосигмоидальный отдел	41	53,2
Слепая кишка	14	18,2
Восходящая ободочная кишка	6	7,8
Поперечноободочная кишка	9	11,7
Нисходящая ободочная кишка	7	9,1
Всего	77	100%

Как видно из таблицы 2 в левой половине толстой кишки, опухоль локализовалась у 48(62,3%), в правой половине у 20 (26,0%) и в поперечно ободочной кишке у 9 больных (11,7%).

Изучения операционного материала позволило, что в левой половине опухоли имели эндофитный рост, а в правой половине чаще экзофитный рост. Микроскопические строение опухоли изучали по операционным материалам и наиболее часто встречались аденокарциномы различной дифференцировки.

Больные были распределены в зависимости от клинической стадии болезни по Б.Е. Петерсону и Н.Н. Блохину (1979). При этом у большинство оперированных больных отмечен РОК IIIA и IIIB стадии.

В клинике разработана методика ранней диагностики толстокишечной непроходимости и степени обструкции с применением металлических контрастных меток (рац. удостоверение №1558, выд. ТГМУ от 28.08.95г)

Суть метода заключается в следующем. Натощак перорально больному дается металлические шарики одновременно со 100 мл жидкой бариевой взвеси. Указанное количество контрастной массы резко снижает возможность получения эффекта наслаивания друг на друга контрастированных кишечных петель. Затем через 2-4-6, а при

необходимости и более часов проводится обзорная рентгенография органов брюшной полости, либо УЗИ брюшной полости. При наличии стеноза или непроходимости «контрастные метки» задерживаются в области препятствия при непроходимости, а при формирующем стенозе пассаж бариевой взвеси происходит беспрепятственно. Указанная методика успешно применена 30 больным.

В зависимости уровня локализации непроходимости нами проведены следующие виды операций:

При правосторонней локализации на первом этапе сформировали илеотрансверзоанастомоз с отключением правой половины ободочной кишки (2) или формировали двустольную илеостому (2) с дренированием зоны абсцесса, через 2-4 месяца выполняли правостороннюю гемиколэктомию. Ещё двум больным с декомпенсированной клиникой непроходимостью правой половины толстой кишки в начале формировали цекостому с декомпрессией тонкой кишки, через 1,5 месяца произвели субтотальную колэктомию с ликвидацией цекостомы с формированием Y-образного анастомоза.

При обструкции поперечно-ободочной кишки проводили левостороннюю гемиколэктомию с формированием трансверзоректоанастомоз (4), субтотальная колэктомия с формированием Y-образного анастомоза (2), резекция поперечно-ободочной кишки по Гартману (3).

Наиболее большое количество больных были с кишечной непроходимостью левосторонней локализации. Ими проводили различные по характеру операции (таблица №3).

Для повышения физической и биологической герметичности асцендоректального 10 больным линия швов укреплена пластинками ТахоКомба в сочетании с антибиотиками (Уведом. о положит. результат. по приорит. спр. № 01000666 от 5.06.2001 г.) 5 пациентам произведена левосторонняя гемиколэктомия с перевязкой нижнебрюшной артерии и вен с формированием Y-образного трансверзоректального анастомоза.

В ближайшем послеоперационном периоде экзатировали 12 больных (15,6%). Причиной летальности у 7 больных была тяжелая интоксикация вследствие перитонита, на почве несостоятельности анастомоза, у 2-острая сердечно-сосудистая недостаточность, ещё у 1-острая печеночно-почечная недостаточность, у 1-послеоперационная пневмония и 1 больной умер от тромбоэмболии легочной артерии. Нагноение послеоперационной раны наблюдались у 11(14,2%).

Заключение

Таким образом, ранняя диагностика и квалифицированная оказанная помощь, больным с обтурационной толстокишечной непроходимости, с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести патологий, распространенности процесса, значительно влияет на успех

Таблица №3

Вид операции	О т д е л локализации опухоли		Всего	Число умерш.
	Нисх. отдел	Ректо- сигмо- идный отдел		
Дистальная субтотальная резекция толстой кишки с формированием асцендоректального анастомоза	2	7	9	1
Дистальная субтотальная резекция толстой кишки с перевязкой а. mesenterica inferior и формированием асцендоректального анастомоза	1	8	9	2
Дистальная субтотальная резекция толстой кишки с перевязкой а. mesenterica inferior и формированием асцендоректального анастомоза. Укрепление линии швов пластинами Тахокомба	1	9	10	
Левосторонняя гемиколэктомия с перевязкой а. mesenterica inferior и формированием трансверзоректального анастомоза		5	5	2
Левосторонняя гемиколэктомия с трансверзоректальным анастомозом	1	4	5	2
Операция Гартмана		7	7	
Проксимальная трансверзостомия	2	4	6	
Всего	7	41	48	7

лечения.

Применение современной технологии, в частности видеолaparоскопия, при затруднительных случаях дает возможность своевременно ставить диагноз и выбрать правильную хирургическую тактику.

Применение пластины ТахоКомба укрепляет физическую и биологическую герметичность линии анастомоза.

Литература

1. Ганцев Ш.Х. и др. Рак ободочной и прямой кишки. М., 2004.
2. Ефимов Г.А., Ушаков Ю.М. Осложненный рак ободочной кишки. М., 1984.
3. Кандаков О.К. Пути улучшения диагностики и хирургического лечения толстокишечной непроходимости опухолевого генеза. Автореф. канд.мед.наук. Душанбе, 2007, 15 с.